



Centre des opérations d'urgences de sante publique « COUSP-RDC »

Rapport de Situation de la Maladie à Virus Ebola/16ème épidémie

SitRep MVE N° 38/MVE_16/2025

Pays/Province	RDC/Kasaï
Zone de Santé touchée	BULAPE
Date de rapportage	13 octobre 2025
Date de publication	14 octobre 2025

53	11	34	5,5 %	68,6 %	18	37 240	31 043
Cas Confirmés	Cas probables	Décès confirmés	Taux d'occupation des lits chez les confirmés	Taux d'occupation des lits chez les suspects	Guéris	Doses de vaccin déployées	Personnes vaccinés

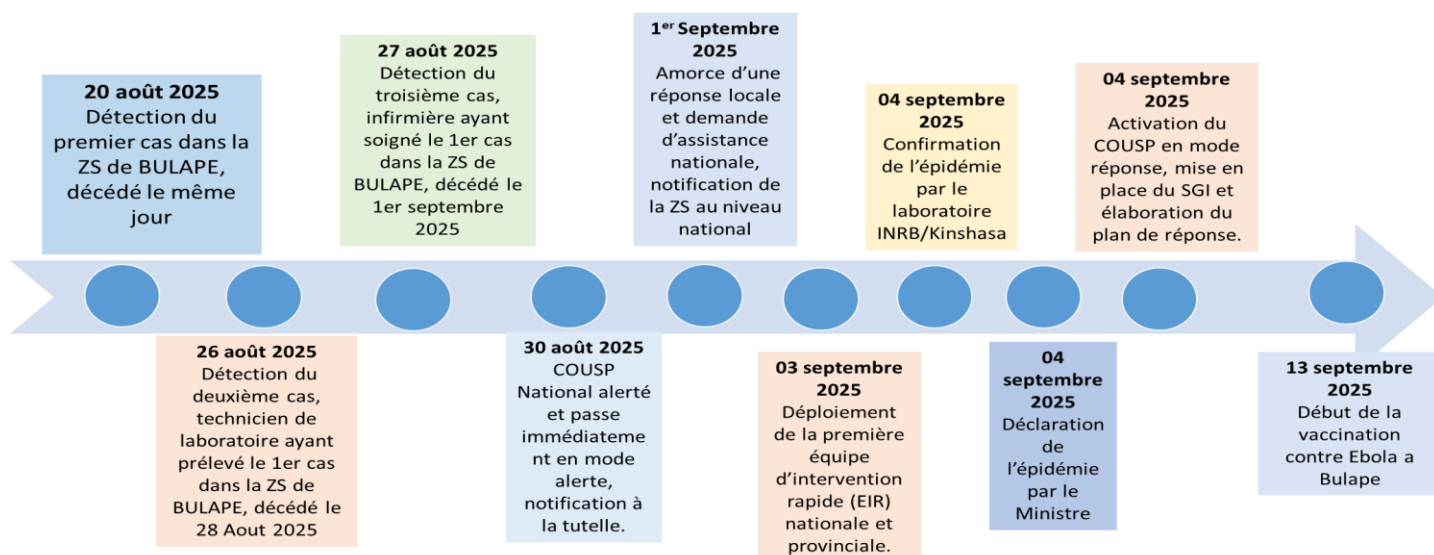
I. POINTS SAILLANTS

- ☒ Aucun nouveau cas n'a été confirmé en ce jour.
- ☒ Déploiement des acteurs de Surveillance (ACoDD, OMS et MSPHPS) dans toutes les 21 AS de la ZS de Bulape.

NARRATIF DU CAS INDEX PRESUME (Contexte)

Le 20 août 2025, une femme enceinte de 20 ans a été admise au service de gynéco-obstétrique de l'HGR de Bulape, présentant la fièvre, la diarrhée sanglante, des vomissements hémorragiques et une anémie sévère. Elle est décédée quelques heures plus tard dans un tableau de défaillance multi viscérale. Dans les jours qui ont suivi, un technicien de laboratoire et une infirmière ayant été en contact avec la patiente ont manifesté les mêmes symptômes et sont également décédés. Entre les semaines épidémiologiques 34 et 36, treize cas ont été notifiés, dont huit décès, soit un taux de létalité de 62 %. L'épidémie a été officiellement déclarée à la suite de la confirmation de cinq cas positifs par l'INRB en date du 04 septembre 2025.

II. CHRONOLOGIE DES FAITS MARQUANTS



III. MISE A JOUR DE LA SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

- ☑ Aucun nouveau cas confirmé n'a été notifié en date du 13/10/2025.
- ☑ La date de la dernière notification d'un cas confirmé remonte au 26 septembre 2025. Ainsi, nous sommes au dix-septième jour sans notification d'un cas confirmé.
- ☑ Depuis le début de l'épidémie, 64 cas (53 confirmés et 11 probables) dont 45 décès ont été rapportés dans la zone de santé de Bulape, soit une létalité globale de 70,3% (Tableau I).
- ☑ La létalité parmi les cas confirmés est de 64,2% (34 décès/53 cas confirmés).
- ☑ Le nombre d'aires de santé ayant notifié au moins un cas confirmé ou probable de MVE depuis le début de l'épidémie demeure à 6 (28,6%) sur les 21 que compte la ZS de Bulape (Tableau I ; Figure 2).

Tableau I : Répartition des cas et décès confirmés et probables de maladie à virus Ebola dans la zone de santé de Bulape, au 13 octobre 2025

Aire de santé affectée*	Nouveau(x) cas confirmé(s)	Cumul des cas et décès				Date de notification du dernier cas confirmé	Nombre de jours sans nouveau cas notifié
		Confirmés	Décès confirmés	Létalité (%)	Probables		
Bambalaie	0	4	2	50,0%	0	20/09/2025	24
Bulape	0	16	14	87,5%	8	26/09/2025	17
Bulape com.	0	4	4	100,0%	1	20/09/2025	23
Dikolo	0	25	14	56%	1	26/09/2025	17
Ingongo	0	1	0	0,0%	0	13/09/2025	28
Mpianga	0	3	0	0,0%	1	22/09/2025	20
Total	0	53	34	64,2%	11		

**Les cas et les décès sont répartis par aire de santé de détection et ces chiffres sont susceptibles de changer.*

On observe depuis quelques jours, une hausse de la létalité dans l'AS de Bulape passant de 64,7% le 05/10/2025 à 87% le 11/10/2025. Cependant, la létalité la plus élevée est attribuable à l'aire de santé de Bulape Com, soit un taux de létalité de 100 %. Par ailleurs, les aires de santé de Bulape et de Dikolo détiennent la majorité des cas confirmés ainsi que des décès enregistrés.

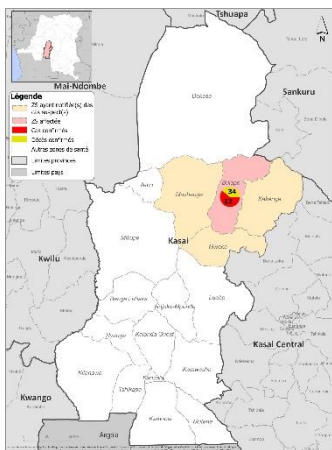


Fig 1. Répartition géographique des zones de santé affectées par la MVE et celles à risque dans la province du Kasai, au 13 octobre 2025

La ZS de Bulape demeure l'unique ZS avec des cas confirmés et des décès, sur l'ensemble des ZS ayant notifiés des cas suspects. A ce jour, la létalité est à 64,2%

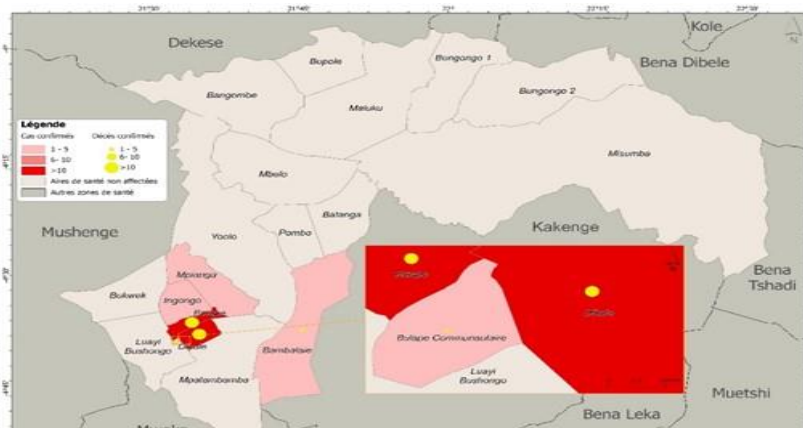


Fig 2. Répartition géographique des cas et décès confirmés par Aires de Santé dans la ZS de Bulape au 13 octobre 2025

Les aires de santé de **Bulape** et de **Dikolo** sont les plus touchées, à la fois en terme du nombre de cas confirmés et des décès enregistrés.

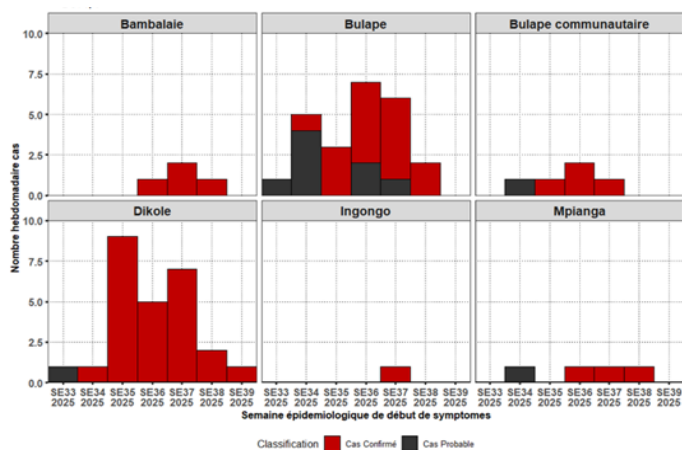


Fig 2. Répartition géographique des cas confirmés et probables par Aires de Santé dans la ZS de Bulape au 13 octobre 2025

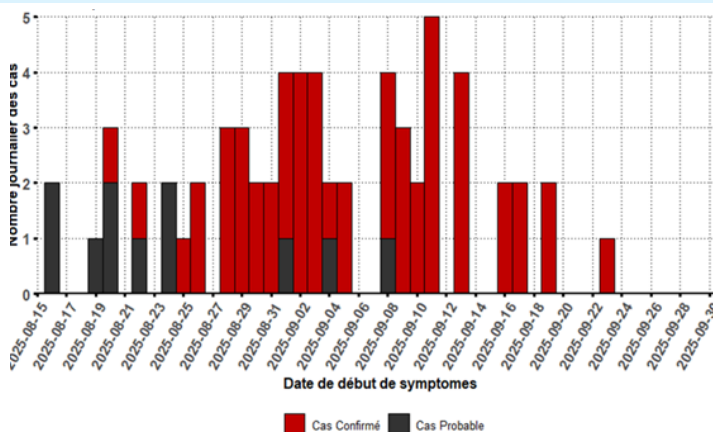


Fig 4. Evolution journalière des cas confirmés et probable au 13 octobre 2025.

En considérant les AS de BULAPE et DIKOLO comme principaux foyers de l'épidémie dans la ZS de Bulape, il ressort que durant les SE 35 à 36, l'AS de Dikolo a enregistré le plus grand nombre de cas notifiés. Cependant, à partir de la SE37 jusqu'au SE38, une tendance à la hausse des cas confirmés est observée dans l'AS de Bulape

Sur la période allant du 27 Aout au 13 septembre, l'analyse journalière met en évidence la survenue de trois clusters des cas confirmés. Par la suite, à compter du 15 septembre ; les notifications deviennent sporadiques, traduisant une diminution progressive de la transmission communautaire.

Tableau 2. Répartition des alertes reçues, investiguées et validées par aire de santé, du 13 octobre 2025

INDICATEURS	07/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	10/10/2025	11/10/2025	12/10/2025	13/10/2025
Report alertes	2	4	10	6	6	23	0
Nouvelles alertes signalées du jour	26	39	6	41	29	57	73
Total alertes du jour	28	43	16	47	35	80	73
Alertes investiguées du jour	17	32	10	33	23	80	70
Alertes validées du jour	7	20	6	16	12	24	16
Suspects prélevés	0	20	5	8	8	17	13
Transférés au CTE	7	10	5	4	8	17	13

NA : non applicable ; ND : non disponible

Le nombre moyen d'alertes journalières rapportées cours de 7 derniers jours (du 07/10/2025 au 13/10/2025) est de 46. Parmi les alertes du jour, deux MAPI ont été signalées.

Tableau 3. Synthèse de la situation du suivi de contacts au 13 octobre 2025

Aire de Santé	Suivi journalier						Taux de suivi	Total non vus	Raison de non vus						
	Report du 10/10/2025	Nouveaux contacts du 11/10/2025	Contact à suivre ce jour	Contacts vus	Sorties 21 Jrs	Devenus Suspects			Simple Absence	Perdus de vue (≥72 heures)	Jamais vus	Refus	Déplacés	Reco n'est pas passé	Reste à suivre le jour suivant
Bambalayi	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Bulape	123	0	123	123	0	0	100%	0	0	0	0	0	0	0	123
Bulape Com	31	0	31	31	0	0	100%	0	0	0	0	0	0	0	31
Dikolo	155	0	155	152	0	0	98%	3	0	0	0	0	3	0	155
Ingongo	0	0	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Mpianga	18	0	18	18	0	0	100%	0	0	0	0	0	0	0	18
Total	327	0	327	324	0	0	99%	3	10	28	0	0	15	0	327

Pour un ensemble de 327 contacts à suivre, 324 contacts ont été vus soit une proportion de suivi de 99%.
Trois (3) contacts sont en déplacement.

IV. ACTIONS DE REPONSE

COORDINATION

- ☒ Tenue de la réunion de coordination.

SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE

- ☒ Répartition des acteurs du Pilier Surveillance (ACoDD, OMS et MSPHPS) dans toutes les 21 AS de la ZS de Bulape ;
- ☒ Investigation des alertes notifiées par la RA lors de la descente de l'équipe conjointe dans l'AS Bukwek ;
- ☒ Investigation des cas de mortalité animale (un chien et un porc) dans l'AS Bulape.

Points sur la surveillance aux Points d'entrée et Points de Contrôles (PoE/PoC)

- ☒ Pour la journée du 13 octobre 2025, un total de 5 333 voyageurs ont été enregistrés dans les 5 PoC opérationnels (4 à Bulape et 1 à Luebo). Tous (100%) ont été screenés et ont procédé au lavage des mains. **Une** alerte a été signalée au cours de cette journée.

LABORATOIRE

- ☑ Pour la journée 13/10/2025, 29 échantillons ont été reçus (17 nouveaux cas suspects et 12 réprélèvements, dont 2 de Mweka). Tous les échantillons de réprélèvement sont revenus négatifs. Aucun nouvel échantillon des cas suspects n'est revenu positif.
- ☑ De tous les échantillons analysés depuis le début, 53 cas confirmés ont été diagnostiqués positifs à la MVE.

Tableau 4. Synthèse de la situation des échantillons reçus et analysés au laboratoire du 13 octobre 2025

Indicateurs	Données
Échantillons reçus (total)	29
Nouveaux cas suspects	17 (1 swab)
Réprélèvements	12
Échantillons analysés	29
Réprélèvements analysés	12 (Tous négatifs)
Résultats des tests	
En cours d'analyses	0
Cas confirmés du jour	0
Non-cas du jour	17
Total des cas confirmés	53

PRISE EN CHARGE HOLISTIQUE (MÉDICALE, NUTRITIONNELLE & PSYCHOSOCIALE)

Tableau 4. Situation des patients hospitalisés dans les centres de traitement Ebola (CTE), centre de transit (CT) ou assimilés en date du 13 octobre 2025

CI/CT/CTE	Cas suspects				Cas confirmés			Guéris	
	Nombre de lits	Nouvelle admission	Total cas au terme de la journée	Taux d'occupation (%)	Nombre de lits	Nombre de cas	Taux d'occupation (%)	Guéris du jour	Cumul guéris
CTE HGR Bulape	16	13	14	87,2%	18	1	5,5%	0	18
CT Bambalayi	10	2	5	50%	0	0	0%	0	0
CT Ingongo	5	0	5	100%	0	0	0%	0	0
CT Mpianga	4	0	0	0,0%	0	0	0%	0	0
Total	35	15	24	68,6%	18	1	5,5%	0	18

- ☑ Au cours de la journée du 13 octobre 2025, les structures de prise en charge ont enregistré 15 nouvelles admissions, dont 13 au CTE HGR Bulape et 2 au CT Bambalayi. Au total, 25 patients sont hospitalisés, dont 24 cas suspects et 1 cas confirmés de MVE, avec des taux d'occupation de 68,6 % pour les suspects et 5,5 % pour les confirmés.
- ☑ Depuis le début de l'épidémie, 18 personnes ont été déclarées guéries et sorties du CTE et le traitement spécifique (Mab114/Ebanga) a été administré à 31 patients.

Activités phares du pilier

- ☒ Laparotomie exploratrice d'un abdomen chirurgical aigu indiquée pour péritonite sur perforation typhique dans la continuité des soins.
- ☒ Identification d'un bâtiment à réhabiliter pour usage d'un CTE à Mweka.
- ☒ Soutien alimentaire de 25 patients au CTE Bulape et CT Ingongo.
- ☒ Distribution générale de vivres à 3 ménages.
- ☒ Prise en charge de 6 enfants de moins de 59 mois MAS dont 1 cas suspect au CTE et 5 dans l'HGR Bulape.
- ☒ Evaluation des aspects de la PEC nutritionnelle au CS Bulape com.
- ☒ 644 personnes (110 H, 130 F, 212 filles & 1924 garçons) venues de 88 ménages et réparties dans 4 quartiers (Bambalaie, Dikolo, Bulape et Bulape -Com) ont bénéficié du soutien psychoéducatif sur la MVE.
- ☒ Poursuite de la prise en charge psychologique de 3 nourrissons (1 filles & 2 garçons) a la crèche dont un orphelin guéri et 2 séparés de leurs mères.
- ☒ Réinsertion communautaire du nourrisson orphelin guéri (1 garçon) au village Ndambu dans l'aire de sante de Bambalaie.
- ☒ Soutien psychologique aux 2 PPL (2H) au centre de transit de Bambalaie.

PREVENTION ET CONTRÔLE DE L'INFECTION (PCI/WASH)

- ☒ Poursuite de la décontamination et démantèlement de l'ancien CTE J6/7.
- ☒ Activités réalisées autour de l'alerte (revenu négatif) du CSR Kinda 1 dans la ZS de KAKENGE.
- ☒ Réalisation des évaluations PCI et accompagnement de 3 ESS sur l'Axe BUKWEK (PS IBONTSHI, PS BETANG YAW et PS MASANGU).
- ☒ Réalisation d'un EDS du décès survenu à l'HGR Bulape.
- ☒ Poursuite de la dotation des kits PCI dans 3 écoles (EP2 DISANGA , EP2 TSHITOKA et Complexe scolaire LA CONNAISSANCE)

VACCINATION

- ☒ Poursuite de la vaccination géographique.
- ☒ Ratissage à Mpianga, Ingongo et Bambalaie.

COMMUNICATION SUR LES RISQUES ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

- ☒ Plaidoyer du Chef de groupement de Bambalaie et chefs des villages pour leur engagement dans la sensibilisation de la communauté sur les mesures préventives contre MVE ainsi l'utilisation des services de soin disponibles au centre de santé.
- ☒ Sensibilisation sur les mesures préventives de la MVE auprès de gardes malades au centre de santé Bambalaie. 80 personnes dont 50 femmes touchées.
- ☒ Sensibilisation sur l'adoption des mesures préventives de la MVE et l'importance de la scolarisation des enfants dans plusieurs écoles dont :Institut Katoka, ITA Mpembe, Institut Lola dans l'AS Mpatambamba et ITM Bulape, EP Mbumba. Au total, 1,636 élèves dont 918 filles et 22 enseignants ont été sensibilisés.
- ☒ Sensibilisation autour des sites de vaccination
- ☒ Descente dans les aires de santé de Mpatambamba et Bambalaie pour des activités CREC de préparation :
- ☒ Une équipe du CREC s'est rendue dans les AS de Mpatambamba et Bambalaie afin de planifier les activités de sensibilisation sur la promotion des mesures de prévention de la MVE. À l'occasion des séances de sensibilisation ont été organisées dans les écoles et au CS.
- ☒ Remontée d'une alerte d'un écolier de l'EP Bulape ayant présenté des vomissements.

LOGISTIQUE

- ☑ Tenue des inventaires et déplacement d'intrants du dépôt de la Zone de Santé vers le dépôt PAM.
- ☑ Réception des intrants (EPI, sac mortuaire, gel alcoolique) dotation de FHI 360.
- ☑ Elaboration de la requête Maintenance et réparation des Motos de la riposte contre la MVE.
- ☑ Appui logistique aux interventions des équipes sur le terrain (vaccination, PCI, Surveillance, PEC et Point d'entrée).

PSEA

- ☑ 2050 personnes, dont 815 filles et femmes ont été touchées par des sensibilisations communautaires sur les MGP des EAS, sur le circuit de référencement et l'assistance aux victimes ; dans les villages Tshikapa, Kalamba et Ndambo.
- ☑ Participation à la tribune populaire organisée conjointement avec la CREC.
- ☑ Sensibilisation des 30 U-Report (dont 4 filles) sur la PSEA.
- ☑ Distribution des affiches et des dépliants de sensibilisation sur la PSEA.
- ☑ 10 leaders religieux et 10 enseignants des 4 écoles du village Ndambo As bambalaie ont été sensibilisés.
- ☑ Sensibilisation de la communauté sur les mesures de PSEAH, y compris les mécanismes des signalements: 407 jeunes (175 filles) y ont pris part.

RECHERCHE

- ☑ **Identification de l'origine du virus et mode de transmission ;**
 - Évaluation des populations animales pouvant servir de réservoirs.
 - Contrôle de la faune pour limiter les contacts humains-animaux à risque.
- ☑ **Analyse des perceptions, comportements et facteurs socioculturels favorisant la transmission :**
 - Études sur la santé mentale et le bien-être des communautés affectées.
 - Recherche sur la stigmatisation des malades, survivants et des familles et du personnel de santé.
 - Analyse des liens entre Ebola, suicides et comportements suicidaires.

SURETE ET SECURITE

- ☑ Monitoring sécuritaire quotidien

IV. DEFIS ET GAPS

- ☑ Mauvais état de route pour atteindre les différents villages des AS affectées.
- ☑ Insuffisance des ressources pour la mise en place d'une réponse holistique.

V. RECOMMANDATIONS

- ☑ Poursuite les investigations approfondies afin de déterminer la source de l'épidémie.
- ☑ Intensifier les activités de vaccination géographiques dans les villages des AS faiblement couverts
- ☑ Poursuivre la vaccination des contacts et la visite des campements en effectuant le suivi des contacts encore actifs

VI. PHOTOS DE TERRAIN

Sensibilisation des 30 U-Report sur la PSEA



9 animaux pris au piège dont 2 chauve-souris et 7 rongeurs



Réalisation d'un EDS à l'HGR Bulape



Prise en charge médicale des cas au CTE HGR Bulape



**POUR TOUTE
INFORMATION
SUPPLÉMENTAIRE,
VEUILLEZ CONTACTER**

Pour l'Institut National de la Santé Publique (INSP) de la RDC

Le Directeur Général de l'INSP

Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné

Tel. : +243 816 040 145

E-mail : dieudonnemwambakazadi@gmail.com

Le Coordonnateur COU-SP

Prof NGANDU Christian

Tél. : +243998091915

E-mail : nganduchristian@ymail.com

L'Incident Manager SGI MVE Epi16

Dr. KITENGE OMASUMBU Richard

E-mail : Richard.kitenge@insp.cd

Pour l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS/RDC)

Le Représentant ai de l'OMS en RDC

Dr ELOVAINIO Riku Edward

E-mail : elovainior@who.int

Incident Manager de l'OMS dans la réponse MVE

Dr Mory Keita

E-mail: makeita@who.int

Le Team Lead Cluster EPR de l'OMS en RDC

Dr Mouctar Diallo

E-mail : dialloam@who.int

